

Fratura exposta · Gustilo e ATB precoce

Fratura exposta é emergência: ATB precoce, antitetânico, limpeza cirúrgica e estabilização. A classificação de Gustilo orienta cobertura e urgência.

ATB de porta

Dica - ATB de porta

Inicie o mais cedo possível (ideal <3 h). Cefalosporina 1^a/2^a para I–II; acrescente Gram" (aminoglicosídeo ou equivalente) e, se contaminação rural/clostruídios, penicilina conforme protocolo.

Quanto maior a energia e a lesão de partes moles, maior a chance de infecção e necessidade de cobertura.



Passos obrigatórios

- ABC do trauma, controle de hemorragia, alinhamento e imobilização
- Cobertura estéril úmida; não 'explorar' ferida na sala de emergência
- Profilaxia antitetânica conforme histórico vacinal
- Centro cirúrgico: irrigação abundante, desbridamento, fixação (externa se grave)

III — subtipos

Subtipo | Característica

- IIIA | Cobertura óssea possível com partes moles
- IIIB | Precisa retalho / perda extensa
- IIIC | Lesão arterial que exige reparo

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Atraso de antibiótico aumenta infecção — priorize ATB sobre 'espera do ortopedista'. Tipo IIIC: ameaça de membro; vascular + ortopedia juntos.